



MÓDULO 8

## Abordagem integrada e inovação nas DCNT

Rui Poínhos  
ruipinhos@utad.pt

Cecília Morais  
ceciliam@utad.pt

### Conteúdos

#### 1. Promoção da saúde e intervenção multidisciplinar

- 1.1. Saúde, bem-estar e qualidade de vida
- 1.2. Da psicologia da saúde à intervenção nutricional nas DCNT
- 1.3. Abordagem multidisciplinar na saúde e na doença

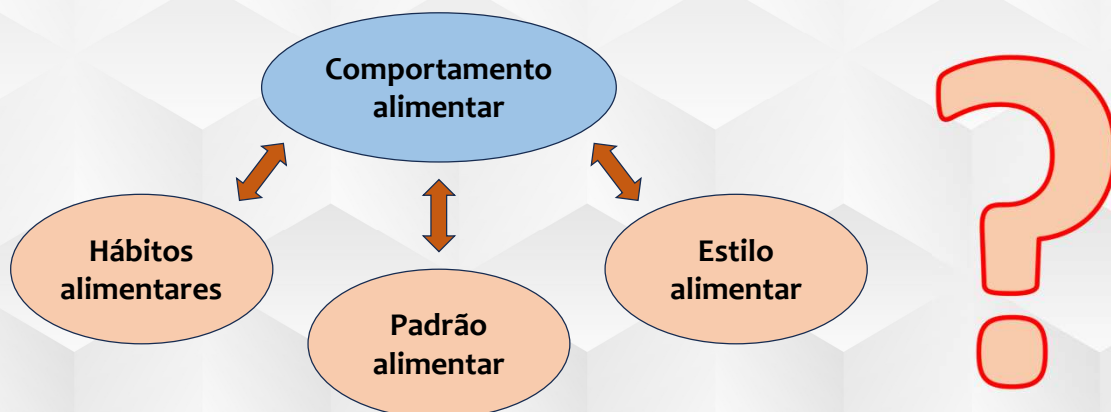
#### 2. Mudança de comportamentos em nutrição e saúde

- 2.1. Modelos de mudança comportamental
- 2.2. Comportamento alimentar: conceitos, avaliação e uso clínico

## Objectivos

- Conhecimento teórico e conceptual:
  - Nutrição clínica, saúde pública;
  - Relação com outras áreas do conhecimento (Psicologia).
- Investigação:
  - Desenvolvimento de estudos;
  - Interpretação de resultados.
- Intervenção:
  - Pistas no discurso;
  - Associações entre dimensões e entre comportamentos.

## Comportamento alimentar



## Definições

### **Hábitos alimentares**

- Quais os alimentos consumidos, em que quantidades e em que circunstâncias são consumidos (local, companhia).

### **Padrão alimentar**

- Quantidades, proporções, frequência, variedade e combinação de todos os alimentos e bebidas consumidos.

### **Comportamento alimentar**

- Aspectos quantitativos e qualitativos relacionados com a selecção e decisão sobre os alimentos a consumir.
- Motivos e processos cognitivos relacionados com a alimentação e os hábitos alimentares.

### **Estilo alimentar**

- Padrões de comportamento alimentar.

USDA, 2014; LaCaille, 2013; Viana, 2002

## Restrição alimentar: diferentes tipos de controlo

### • **Restrição alimentar**

- Tendência para restringir a ingestão de alimentos com o objectivo de controlar o **peso** corporal.
- Caracteriza-se por **resistência auto-imposta aos estímulos** internos e externos que regulam o comportamento alimentar e, concretamente, a ingestão de alimentos.
- Algumas pessoas com elevados níveis de restrição não são bem sucedidas na **manutenção** de um peso corporal adequado.
  - Estratégia útil para o controlo ponderal **vs.** associação positiva com o peso corporal.



### • Mecanismos explicativos:

- Diferença entre restrição enquanto **intenção** e enquanto **comportamento**;
- **Constância** do comportamento restritivo.

Elfhag & Morey, 2008; Herman & Mack, 1975; van Strien et al., 2012; Viana, 2002; Boschi et al., 2001; Stice et al., 2004, 2007, 2010

## Restrição alimentar: diferentes tipos de controlo

- Diferença entre a restrição enquanto intenção e enquanto comportamento
  - O **insucesso** nas tentativas de restrição pode levar a que indivíduos com tendência para ingestão excessiva **aumentem de peso** apesar de serem classificados como restritivos.
- Constância do comportamento restritivo
  - A restrição associa-se a **maior ingestão após consumo prévio** (*preload*).
  - Mecanismo oposto ao verificado em indivíduos não restritivos, que tendem a comer menos após uma primeira ingestão.

Rotenberg & Flood, 2000; Stice, 2002; Stroebe, 2008; Wardle & Beales, 1987

## Restrição alimentar: diferentes tipos de controlo

- Dificuldade do organismo em distinguir entre **inibição auto-imposta** do consumo alimentar e a **baixa disponibilidade** de alimentos faz com que a restrição possa levar a posterior desinibição alimentar.
  - As pessoas restritivas alternam habitualmente entre **ciclos de restrição e de desinibição**, pois o controlo cognitivo é interrompido por factores emocionais, cognitivos ou químicos.

Diferentes tipos de restrição

Chaput et al., 2009; Elfhag & Linné, 2005; Goldsmith et al., 2010; Herman & Polivy, 1980; van Strien et al., 2009

## Restrição alimentar: diferentes tipos de controlo

### Controlo rígido

- Envolve atitudes dicotómicas em relação, por exemplo, aos alimentos a excluir da alimentação.
- Relacionado com maior desinibição e maior ingestão após consumo prévio.

### Controlo flexível

- Normas auto-impostas menos estritas.
- Relacionado com níveis inferiores de desinibição.

No entanto, os dois tipos de restrição encontram-se em geral associados positivamente.

Gallant et al., 2010; Masheb & Grilo, 2002; Shearlin et al., 1994; Stewart et al., 2002; Timko & Perone, 2005; Viana, 2002; Westenhoefer, 1991; Westenhoefer et al., 1994, 1999, 2013

## Restrição alimentar: diferentes tipos de controlo

### Sub-escalas de controlo rígido e flexível do comportamento alimentar

- Avaliação dos dois tipos de restrição.
- Total de 25 itens (versão original: 28):
  - Controlo rígido: 14 itens; controlo flexível: 11 itens.
  - Itens de resposta dicotómica e de resposta em escala de 4 pontos.

#### ADAPTAÇÃO E VALIDAÇÃO DAS SUB-ESCALAS DE CONTROLO FLEXÍVEL E RÍGIDO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR

Polinhos R<sup>1</sup>, Rowcliffe P<sup>2</sup>, Marques AB<sup>3</sup>, Viana V<sup>3\*</sup>, Oliveira BMPM<sup>4</sup>, Correia F<sup>5,6\*</sup> • *Alimentação Humana* 2013; Volume 19, N.º 1

#### Exemplos de itens:

Leia cada uma das frases seguintes e decida se o que ela transmite é Verdadeiro ou Falso relativamente à sua maneira de ser habitual. Assinale com uma cruz o quadrado correspondente à sua resposta.

1. Tento aderir a um plano quando perco peso. (Verdadeiro / Falso) [CR01]
2. Se comer um pouco mais durante uma refeição, compenso isso na refeição seguinte. (Verdadeiro / Falso) [CF01]

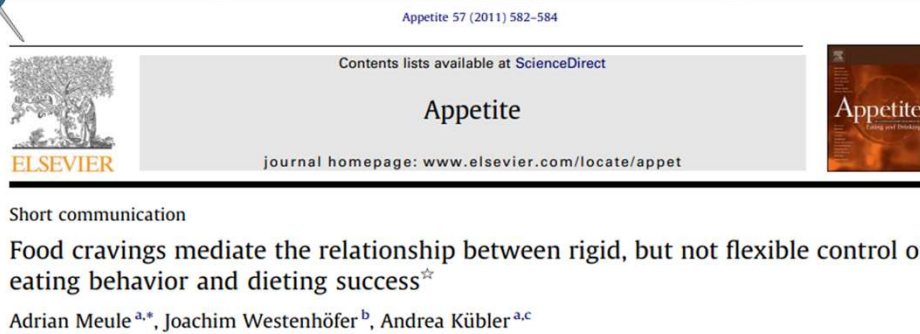
Leia cada uma das perguntas e assinale com uma cruz o quadrado correspondente à sua resposta.

18. Com que frequência evita abastecer-se de alimentos que acha tentadores mas demasiado calóricos? (Quase nunca / Às vezes / Geralmente / Quase sempre) [CR12]
19. Qual a probabilidade de conscientemente comer menos do que o que realmente gostaria de comer? (Não é provável / Pouco provável / Moderadamente provável / Muito provável) [CF10]

Polinhos et al., 2013; Westenhoefer et al., 1999

## Restrição alimentar: diferentes tipos de controlo

### Sugestão de leitura:



Meule et al., 2011

## Restrição alimentar: diferentes tipos de controlo

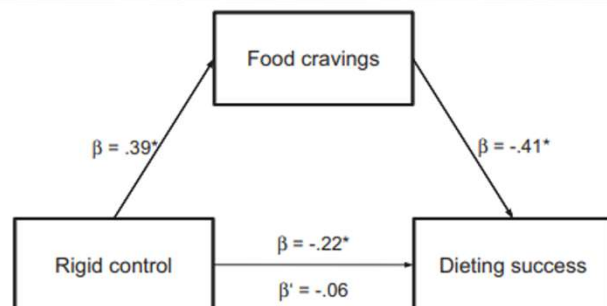
### Results

#### Rigid control

Rigid control was a significant predictor of food cravings ( $F_{(1,478)} = 87.3$ ,  $p < .001$ , adj.  $R^2 = .15$ ) and dieting success ( $F_{(1,478)} = 24.8$ ,  $p < .001$ , adj.  $R^2 = .05$ ). Beta-weights are depicted in Fig. 1. Food cravings also predicted dieting success ( $F_{(1,478)} = 111.3$ ,  $p < .001$ , adj.  $R^2 = .19$ ,  $\beta = -.44$ ). The overall model including both rigid control and food cravings as predictors was also significant ( $F_{(2,477)} = 56.7$ ,  $p < .001$ , adj.  $R^2 = .19$ ). While food cravings were still a significant predictor of dieting success, the influence of rigid control was no longer significant (Fig. 1). Food cravings mediated the relationship between rigid control and dieting success (Sobel  $z = -6.42$ ,  $p < .001$ ).

#### Flexible control

Flexible control predicted dieting success ( $F_{(1,478)} = 34.5$ ,  $p < .001$ , adj.  $R^2 = .07$ ,  $\beta = .26$ ). However, flexible control did not predict food cravings ( $F_{(1,478)} = .58$ , ns, adj.  $R^2 = .00$ ,  $\beta = -.04$ ).



**Fig. 1.** Mediation model showing the mediating influence of food cravings on the relationship between rigid control of eating behavior and dieting success. Standardized  $\beta$ -coefficients are shown for the relation between rigid control and food cravings, food cravings and dieting success (adjusted for rigid control), and rigid control and dieting success ( $\beta'$  indicates the relation which is adjusted for the mediator). Asterisks indicate a  $p$ -value  $< .001$ .

Meule et al., 2011



## Restrição alimentar: diferentes tipos de controlo

### Discussion

In the current study, we found that rigid dietary control strategies were inversely related to dieting success while flexible control strategies were positively associated with dieting success. We could also demonstrate that the experience of food cravings fully mediated the relationship between rigid control and dieting success. Contrarily, flexible control was not related to food cravings and predicted dieting success independent of food cravings.

Our results corroborate and extend previous findings indicating that rigid control is associated with self-regulatory failure in eating behavior (Timko & Perone, 2005; Westenhoefer, 1991; Westenhoefer et al., 1999). The mediating role of food cravings in this relationship is in line with rigid dietary strategies, such as a monotonous diet, eliciting such cravings (Pelchat & Schaefer, 2000). However, these results also contrast positive associations between rigid control and weight loss in overweight and obese women (McGuire et al., 2001; Teixeira et al., 2010). It has to be

predominantly normal-weight sample. However, we speculate that obese patients might have low – both rigid and flexible – dietary control and therefore benefit from increases in rigid control which leads to initial weight loss. On the long run, however, rigid eating behaviors lead to food cravings thereby hampering long-term weight maintenance. Indeed, people with flexible control strategies have been found to be more successful in long-term weight maintenance (Teixeira et al., 2010; Westenhoefer et al., 2004). While flexible control was associated with dieting success in our study, this relationship was not attenuated by food cravings. Accordingly, flexible control was not related to food cravings. Dieters with flexible control strategies may also experience food cravings because they are common and experienced by most people (Hill, 2007). It is possible that even after giving in to such cravings, food intake is properly adjusted afterwards leading to successful weight loss or maintenance. Finally, flexible control in combination with less food cravings fosters dieting success even more.

Meule et al., 2011

## Barreiras ao cumprimento da terapêutica dietética

- 01 Não consigo fazer dieta porque os horários de trabalho/ estudos não permitem
- 02 A dieta prescrita é comida que não apetece comer
- 03 Não sou capaz de cozinhar dieta
- 04 Sinto dificuldade em cumprir porque tenho um estilo de vida muito atarefado
- 05 Sinto que quando estou a cumprir dieta sou diferente de quem está à minha volta
- 06 Onde como não se fazem dietas
- 07 Sinto-me fraco/o quando faço dieta, com falta de forças
- 08 A minha família e amigos gostam de outro tipo de comida
- 09 Fazer dieta é uma grande mudança na minha alimentação habitual
- 10 Tenho dificuldade em encontrar os alimentos da dieta
- 11 A dieta obriga-me a deixar de comer o que gosto
- 12 A dieta é comida diferente da que estou habituado/a
- 13 A comida de dieta é mais cara
- 14 A dieta não é comida suficiente, fico com fome
- 15 Para preparar a dieta perco muito tempo, pois exige uma preparação demorada
- 16 Não tenho força de vontade para fazer dieta
- 17 Eu não quero/conseguí mudar os meus hábitos alimentares
- 18 O aumento de peso é de família
- 19 Ansiedade e nervoso fazem com que eu coma mais
- 20 Quando tenho comida à frente não resisto
- 21 A comida de dieta não é saborosa
- 22 Gosto de comer doces
- 23 As dietas interferem com a vida familiar
- 24 Saber que vou ter que fazer dieta sempre
- 25 Comer diminui-me o nervoso
- 26 Gosto de comer
- 27 Não consigo parar de comer depois de começar
- 28 Penso sempre que amanhã retornarei a fazer a dieta
- 29 Sinto-me insatisfeita/o a fazer dieta
- 30 Não consigo levar uma dieta a sério
- 31 Sinto-me desanimada/o quando faço dieta
- 32 A dieta obriga a cozinhar à parte
- 33 A dieta não me dá prazer
- 34 Sinto-me desconsolada/o a fazer dieta

Correia et al., 2009

## Restrição alimentar: diferentes tipos de controlo

- Que afirmações ou expressões podem indicar um comportamento alimentar caracterizado por controlo rígido?
- Como abordar ou intervir?



## Desinibição, ingestão emocional e ingestão externa

### Desinibição

- Tendência para comer (de)mais em resposta a diferentes estímulos (e.g. presença de alimentos com elevada palatibilidade; stresse emocional).

### Ingestão emocional

- Tendência para comer como resposta inadequada a emoções negativas e ao stresse.

### Ingestão externa

- Tendência para o aumento da ingestão em resposta a estímulos externos relacionados com alimentos (e.g. ver ou cheirar comida).



## Desinibição, ingestão emocional e ingestão externa

- Associação positiva entre ingestão emocional e ingestão externa.
  - Pessoas com elevados níveis de ingestão emocional ou de ingestão externa partilham o facto de serem relativamente **insensíveis aos sinais internos de fome e saciedade**.
  - Podem manifestar-se independentemente, sendo alguns indivíduos mais susceptíveis a um ou a outro tipo de estímulos.
- A ingestão externa e a ingestão emocional levam tendencialmente a uma **ingestão excessiva**, estando associadas ao **aumento de peso** e a **maior IMC**.
- Associação positiva entre **restrição alimentar** e **ingestão emocional**.
- Associação entre **restrição** e **ingestão externa** não é encontrada em todos os trabalhos.

Anschutz et al., 2009; Elfhag & Linné, 2005; Elfhag & Morey, 2008; Koenders & van Strien, 2011; van Strien et al., 1995, 2009, 2012; Racine et al., 2009; Viana & Sinde, 2003

## Desinibição, ingestão emocional e ingestão externa

### Questionário Holandês do Comportamento Alimentar (DEBQ)

- 33 itens (escala de 5 pontos; frequência).
- 3 sub-escalas:

- **Restrição alimentar;**
- **Ingestão emocional;**
- **Ingestão externa.**

Exemplos  
de itens:

4. Quando o seu peso aumenta come menos do que o habitual ?

[R]

- ☐ Nunca
- ☐ Raramente
- ☐ Às vezes
- ☐ Frequentemente
- ☐ Muito frequentemente

O meu peso não se altera ☐

5. Tem desejo de comer quando se sente deprimido ou desanimado ?

[IEm]

- ☐ Nunca
- ☐ Raramente
- ☐ Às vezes
- ☐ Frequentemente
- ☐ Muito frequentemente

Nunca me sinto deprimido ou desanimado ☐

6. Se a comida cheira bem ou tem bom aspecto, come mais do que o habitual?

[IExt]

- ☐ Nunca
- ☐ Raramente
- ☐ Às vezes
- ☐ Frequentemente
- ☐ Muito frequentemente

Viana & Sinde, 2003

## Desinibição, ingestão emocional e ingestão externa

### Three-Factor Eating Questionnaire (TFEQ)

- 51 itens (versão original; outras versões com 21 e 18 itens).
- Três sub-escalas:
  - **Restrição** (R-TFEQ);
  - **Desinibição** (D-TFEQ);
  - **Fome** (H-TFEQ):
    - Sensação de fome e suas implicações comportamentais.

Moreira et al., 1999; Stunkard & Messick, 1985

## Desinibição, ingestão emocional e ingestão externa

### Three-Factor Eating Questionnaire (TFEQ)

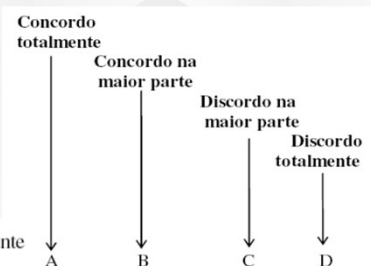
Exemplos  
de itens:

[D] 2. Em ocasiões sociais, como por exemplo festas, geralmente como demais

[H] 3. Tenho normalmente tanta fome que como mais do que três refeições por dia

[R] 37. Com que frequência faz dieta como forma de controlar o peso?

- ☐ Raramente
- ☐ Às vezes
- ☐ Frequentemente
- ☐ Sempre



Moreira et al., 1999

## Desinibição, ingestão emocional e ingestão externa

### Three-Factor Eating Questionnaire (TFEQ)

Ing. externa

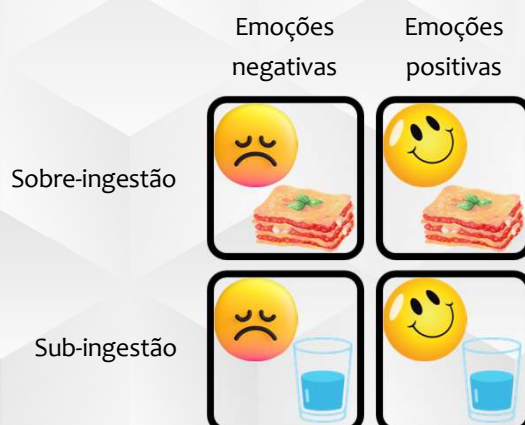
2. I usually eat too much at social occasions, like parties and picnics.
3. I am usually so hungry that I eat more than three times a day.
4. When I have eaten my quota of calories, I am usually good about not eating any more.
5. Dieting is so hard for me because I just get too hungry.
6. I deliberately take small helpings as a means of controlling my weight.
7. Sometimes things just taste so good that I keep on eating even when I am no longer hungry.
8. Since I am often hungry, I sometimes wish that while I am eating, an expert would tell me that I have had enough or that I can have something more to eat.
9. When I feel anxious, I find myself eating.
10. Life is too short to worry about dieting.
11. Since my weight goes up and down, I have gone on reducing diets more than once.
12. I often feel so hungry that I just have to eat something.
13. When I am with someone who is overeating, I usually overeat too.

Ing. emocional

Ing. externa

Stunkard & Messick, 1985

## Desinibição, ingestão emocional e ingestão externa



### • Interacção com a restrição alimentar:

- E.g., a sobre-ingestão emocional como resposta a emoções negativas verifica-se sobretudo em indivíduos restritivos.

Devonport et al., 2019; Evers et al., 2018; Meule et al., 2018

## Desinibição, ingestão emocional e ingestão externa

### Salzburg Emotional Eating Scale

- Quatro factores:
  - Um relacionado com emoções positivas (“felicidade”);
  - Três relacionados com emoções negativas (“tristeza”, “raiva”, “ansiedade”).
- Pontuações mais elevadas indicam **sobre-ingestão** em resposta às emoções; pontuações mais baixas indicam **sub-ingestão** em resposta às emoções.

When I am happy, ...  
When I feel lonely, ...  
When I am angry, ...  
When I am worried, ...



I eat much less than usual  
I eat less than usual  
I eat just as much as usual  
I eat more than usual  
I eat much more than usual

Meule et al., 2018

## Desinibição, ingestão emocional e ingestão externa

### Sugestão de leitura:



frontiers  
in Psychology

REVIEW  
published: 08 December 2016  
doi: 10.3389/fpsyg.2016.01932

### Emotional Eating Is Not What You Think It Is and Emotional Eating Scales Do Not Measure What You Think They Measure

Peggy Bongers\* and Anita Jansen

Bongers & Jansen, 2016

## Desinibição, ingestão emocional e ingestão externa

Experimental studies do not unequivocally support the assumption that high scores on self-reported emotional eating are predictive of actual increased food intake when feeling negative. Although some studies provide evidence in favor of this view, most research is either in contrast or shows ambiguous results. There is no consistent evidence for increased food intake under emotional circumstances in individuals scoring high on self-reported emotional eating.

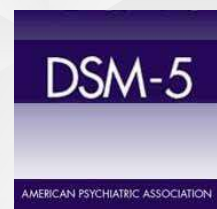
To sum up, high scores on emotional eating scales are related to high scores on several other scales. It has been suggested that they reflect general eating concerns, lack of control, a tendency to attribute overeating to negative affect or being a cue reactive person. These four new interpretations of high scores on emotional eating scales all consider emotional eating to be different from mere and specific overeating in a negative mood.

quick assessment of emotional eating is required. Therefore, it is worthwhile to consider ways to improve the validity of self-report questionnaires. One characteristic of current questionnaires that could induce bias is that they are always framed in a positive way (i.e., “do you have a desire to eat when you are depressed” or “when I feel anxious, I find myself eating”) which might lead individuals to think of instances in which they indeed felt depressed or anxious and ate, while ignoring all other instances in which they felt that way but did not eat. Reframing of the questions so that part of the questionnaire needs to be reverse scored (i.e., “do you have a decreased desire to eat when you are depressed” or “when I feel anxious, I find myself eating less”) could reduce the bias in responding. Another possibility could be to instruct individuals to think of a specific time period, i.e., the past 2 weeks, to prevent recollection of emotional eating events that happened a long time ago and are given undue significance.

Bongers & Jansen, 2016

## Ingestão compulsiva

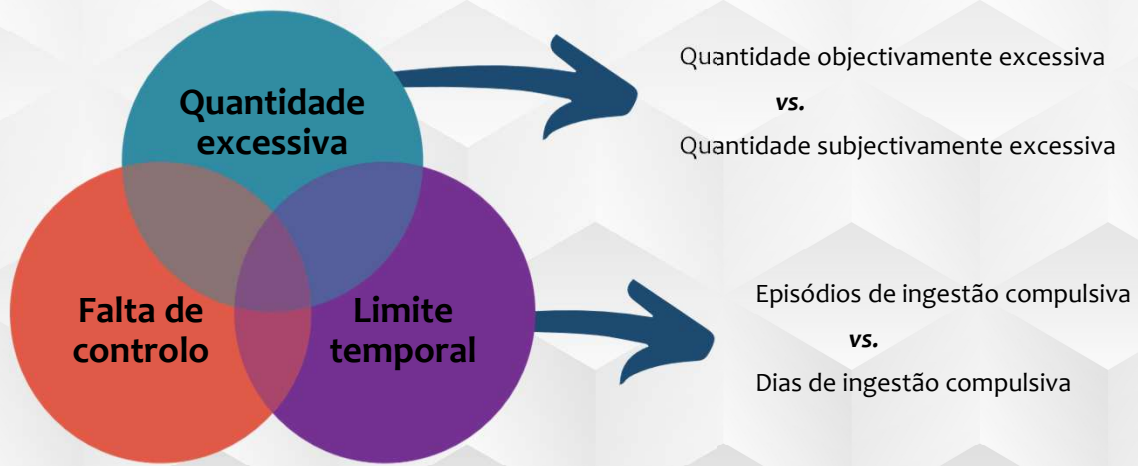
- Consumo de uma **elevada quantidade** de comida num **curto período**, acompanhado pela sensação de **falta de controlo** sobre a ingestão.
- Relacionada com níveis elevados de ingestão emocional e ingestão externa (amostras clínicas e não-clínicas).
- Um episódio de ingestão alimentar compulsiva é caracterizado por:
  1. Comer, num curto período de tempo (por exemplo, até 2 horas), uma quantidade de alimentos sem dúvida superior à que a maioria dos indivíduos comeria num período semelhante e nas mesmas circunstâncias.
  2. Sensação de perda de controlo sobre o acto de comer durante o episódio (e.g. sentimento de incapacidade para parar de comer ou controlar a quantidade e qualidade dos alimentos).



APA, 2013; Racine et al., 2009; Schulz & Laessle, 2010; Wolfe et al., 2009



## Ingestão compulsiva



Wolfe et al., 2009

## Ingestão compulsiva

### Alimentos tipicamente consumidos:

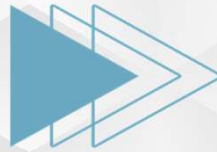
- Snacks, sobremesas.
- Tendência para maior consumo de **hidratos de carbono e gorduras** do que proteínas.
  - Maior consumo de hidratos de carbono durante os episódios de ingestão compulsiva do que em outras refeições (na bulimia nervosa).
- Consumo elevado de **líquidos e alimentos moles** (na bulimia nervosa, para facilitar o vómito).

Wolfe et al., 2009

## Ingestão compulsiva

### Aspectos ambientais

- Em casa, sozinho, em segredo.
- Ao **fim da tarde ou à noite**.
  - Alguns estudos reportam proporções elevadas de episódios em qualquer altura do dia.
- Episódios podem ser **potenciados por**:
  - Começar a comer;
  - Ver alguém a preparar alimentos;
  - Festas e outros eventos;
  - Tempo livre não estruturado.



**Intervenção**

Wolfe et al., 2009

## Ingestão compulsiva

### **Escala de Compulsão Alimentar Periódica**

- Versão portuguesa da *Binge Eating Scale* (BES).
- **Rastreio** e avaliação da gravidade da ingestão compulsiva (em obesos):
  - Sentimentos e cognições envolvidos nos episódios de CAP.
- Não é um instrumento de diagnóstico:
  - Confirmação do **diagnóstico por entrevista clínica**.
- 16 itens (afirmação com que mais se identifica).

Freitas et al., 2001; Tapadinhas & Ribeiro, 2012

### Escala de Compulsão Alimentar Periódica

- Exemplo de item:

- ☐ Normalmente quando como alguma coisa é porque estou fisicamente com fome.
- ☐ De vez em quando como alguma coisa por impulso, mesmo quando não estou realmente com fome.
- ☐ Eu tenho o hábito regular de comer alimentos que realmente não aprecio para satisfazer uma sensação de fome, mesmo que fisicamente eu não necessite de comida.
- ☐ Mesmo que não esteja fisicamente com fome, tenho uma sensação de fome na minha boca que somente parece ser satisfeita quando eu como um alimento [...].

### Sugestão de leitura:



International Journal of  
Environmental Research  
and Public Health



Article

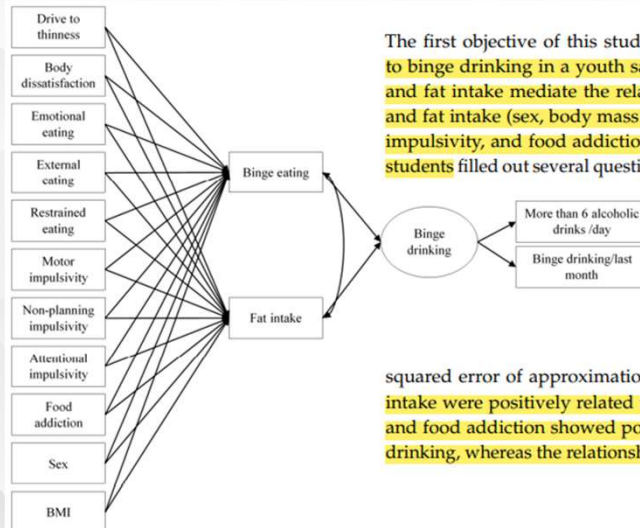
### Understanding the Influence of Eating Patterns on Binge Drinking: A Mediation Model

Tamara Escrivá-Martínez <sup>1,2</sup>, Laura Galiana <sup>3</sup>, Rocío Herrero <sup>2,4</sup>, Marta Rodríguez-Arias <sup>5</sup>  
and Rosa M<sup>a</sup> Baños <sup>1,2,4,\*</sup>

Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 9451; doi:10.3390/ijerph17249451

www.mdpi.com/journal/ijerph

## Ingestão compulsiva



The first objective of this study was to analyze whether binge eating and fat intake are related to binge drinking in a youth sample. The second objective was to analyze whether binge eating and fat intake mediate the relationship between individual factors associated with binge eating and fat intake (sex, body mass index (BMI), drive for thinness, body dissatisfaction, eating styles, impulsivity, and food addiction) and binge drinking. Methods: A sample of 428 undergraduate students filled out several questionnaires on binge drinking, binge eating, fat intake, drive for thinness,

squared error of approximation (RMSEA) = 0.022 [90% CI = 0.000, 0.047]. Binge eating and fat intake were positively related to binge drinking. Furthermore, emotional eating, external eating, and food addiction showed positive and statistically significant indirect relationships with binge drinking, whereas the relationship with restrained eating was negative. Conclusions: These findings

Escrivá-Martínez et al., 2020

## Barreiras ao cumprimento da terapêutica dietética

- |                                                                                    |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 01 Não consigo fazer dieta porque os horários de trabalho/ estudos não permitem    | 16 Não tenho força de vontade para fazer dieta             |
| 02 A dieta prescrita é comida que não apetece comer                                | 17 Eu não quero/consegui mudar os meus hábitos alimentares |
| 03 Não sou capaz de cozinhar dieta                                                 | 18 O aumento de peso é de família                          |
| 04 Sinto dificuldade em cumprir porque tenho um estilo de vida muito atarefado     | 19 Ansiedade e nervoso fazem com que eu coma mais          |
| 05 Sinto que quando estou a cumprir dieta sou diferente de quem está à minha volta | 20 Quando tenho comida à frente não resisto                |
| 06 Onde como não se fazem dietas                                                   | 21 A comida de dieta não é saborosa                        |
| 07 Sinto-me fraco/o quando faço dieta, com falta de forças                         | 22 Gosto de comer doces                                    |
| 08 A minha família e amigos gostam de outro tipo de comida                         | 23 As dietas interferem com a vida familiar                |
| 09 Fazer dieta é uma grande mudança na minha alimentação habitual                  | 24 Saber que vou ter que fazer dieta sempre                |
| 10 Tenho dificuldade em encontrar os alimentos da dieta                            | 25 Comer diminui-me o nervoso                              |
| 11 A dieta obriga-me a deixar de comer o que gosto                                 | 26 Gosto de comer                                          |
| 12 A dieta é comida diferente da que estou habituado/a                             | 27 Não consigo parar de comer depois de começar            |
| 13 A comida de dieta é mais cara                                                   | 28 Penso sempre que amanhã retornarei a fazer a dieta      |
| 14 A dieta não é comida suficiente, fico com fome                                  | 29 Sinto-me insatisfeita/o a fazer dieta                   |
| 15 Para preparar a dieta perco muito tempo, pois exige uma preparação demorada     | 30 Não consigo levar uma dieta a sério                     |
|                                                                                    | 31 Sinto-me desanimada/o quando faço dieta                 |
|                                                                                    | 32 A dieta obriga a cozinhar à parte                       |
|                                                                                    | 33 A dieta não me dá prazer                                |
|                                                                                    | 34 Sinto-me desconsolada/o a fazer dieta                   |

Correia et al., 2009

## Desinibição e ingestão compulsiva

- Que afirmações podem indicar elevada ingestão emocional?
- São ou não indicadores de elevada ingestão emocional?
  - 29 Sinto-me insatisfeita/o a fazer dieta
  - 31 Sinto-me desanimada/o quando faço dieta
  - 34 Sinto-me desconsolada/o a fazer dieta
- Que afirmações podem indicar elevada ingestão externa?
- Que afirmações podem indicar ingestão compulsiva?



## Evitamento da comida e atração pela comida

### Questionário do Comportamento Alimentar da Criança (CEBQ)

- 35 itens (frequência de ocorrência em escala de 5 pontos, de nunca a sempre).

#### Evitamento da comida

- Resposta à saciedade
- Ingestão lenta
- Selectividade alimentar
- Sub-ingestão emocional

#### Atração pela comida

- Resposta à comida
- Prazer em comer
- Sobre-ingestão emocional
- Desejo de beber



## Evitamento da comida e atração pela comida

- **Resposta à saciedade**

- Sensibilidade às pistas internas de saciedade.
  - Consequente maior eficácia no controlo do aporte energético, constituindo protecção face ao consumo alimentar excessivo.
- Parece ser em parte hereditária.
- Relacionada com a idade, sendo as crianças mais jovens as que apresentam maior eficácia no ajuste da ingestão de modo a compensar uma refeição anterior.

- **Ingestão lenta e Selectividade alimentar**

- Falta de prazer e de interesse pelos alimentos.
- Associadas ao baixo peso em crianças.

Viana et al., 2011

## Evitamento da comida e atração pela comida

- **Resposta à comida e Prazer em comer**

- Maior interesse pelos alimentos e maior resposta às pistas externas relacionadas com eles.
- Comportamentos que se tornam mais pronunciados conforme as crianças se tornam menos neofóbicas e mais autónomas face à alimentação.
- Níveis mais elevados associados a maior risco de obesidade.

- **Desejo de beber**

- Pode relacionar-se com maior IMC no caso de bebidas ricas em açúcar (e.g. refrigerantes).

Viana et al., 2011

## Evitamento da comida e atração pela comida

### • Sub-ingestão emocional e Sobre-ingestão emocional

- Reactividade emocional à comida.
- Consequências opostas em termos de peso.
- Atitudes restritivas dos pais e pressão para ingerir alimentos “saudáveis” parecem estar associados à sobre-ingestão emocional, traduzindo-se em desinibição e externalidade que perturbam o mecanismo de controlo da saciedade (em meninas).
- Também o tipo de reactividade ao stress em crianças parece interagir com a restrição, resultando em sub- ou sobre-ingestão.

## Evitamento da comida e atração pela comida

### Questionário do Comportamento Alimentar da Criança (CEBQ)

#### Exemplos de itens:

- O meu filho interessa-se por comida. [Prazer em comer]
- O meu filho está sempre a pedir comida. [Resposta à comida]
- O meu filho termina as refeições muito rapidamente. [Ingestão lenta]
- O meu filho fica cheio antes de terminar a refeição. [Resposta à saciedade]
- Perante novos alimentos o meu filho começa por recusá-los. [Selectividade]
- O meu filho come mais quando está aborrecido. [Sobre-ingestão emocional]
- O meu filho come menos quando está cansado. [Sub-ingestão emocional]
- O meu filho anda sempre a pedir de beber (refrigerantes ou sumos). [Desejo de beber]

## Evitamento da comida e atração pela comida

### Questionário do Comportamento Alimentar da Criança (CEBQ)

#### Exemplos de itens:

- O meu filho interessa-se por comida. [Prazer em comer]
- O meu filho está sempre a pedir comida. [Resposta à comida]
- O meu filho termina as refeições muito rapidamente. [Ingestão lenta]
- O meu filho fica cheio antes de terminar a refeição. [Resposta à saciedade]
- Perante novos alimentos o meu filho começa por recusá-los. [Selectividade]
- O meu filho come mais quando está aborrecido. [Sobre-ingestão emocional]
- O meu filho come menos quando está cansado. [Sub-ingestão emocional]
- O meu filho anda sempre a pedir de beber (refrigerantes ou sumos). [Desejo de beber]

Viana et al., 2011

## Evitamento da comida e atração pela comida

**TABLE 6** Results from random effects meta-analysis of studies examining correlation of CEBQ scales with body mass index (BMI) z-scores (only unadjusted correlation coefficients<sup>a</sup>)

| CEBQ scale | <i>r</i> | 95% CI         | <i>I</i> <sup>2</sup> (%) | <i>p</i> value for heterogeneity | Subcohorts ( <i>n</i> ) | <i>n</i> |
|------------|----------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------|
| FR         | 0.22     | (0.16, 0.29)   | 88.0                      | 0.00                             | 19                      | 9,463    |
| EF         | 0.17     | (0.14, 0.20)   | 49.4                      | 0.00                             | 19                      | 20,416   |
| EOE        | 0.15     | (0.08, 0.22)   | 82.9                      | 0.00                             | 11                      | 7,038    |
| DD         | 0.10     | (0.04, 0.15)   | 82.9                      | 0.00                             | 10                      | 9,219    |
| SR         | -0.21    | (-0.24, -0.17) | 56.7                      | 0.00                             | 17                      | 9,854    |
| SE         | -0.15    | (-0.21, -0.10) | 64.8                      | 0.00                             | 8                       | 5,192    |
| FF         | -0.08    | (-0.10, -0.06) | 0.00                      | 0.99                             | 11                      | 8,855    |
| EUE        | -0.09    | (-0.11, -0.06) | 8.00                      | 0.37                             | 7                       | 7,330    |

Abbreviations: CEBQ, Child Eating Behavior Questionnaire; CI, confidence interval; DD, Desire to Drink; EF, Enjoyment of Food; EOE, Emotional Overeating; EUE, Emotional Undereating; FR, Food Responsiveness; SE, Slowness in Eating; SD, standard deviation; SR, Satiety Responsiveness.

<sup>a</sup>Data for Haycraft et al (2011) were reported as adjusted in the original study. Authors provided raw data to calculate the unadjusted correlation coefficients, and these were subsequently were pooled in the model presented above.

Kininmonth et al., 2021

## Evitamento da comida e atração pela comida

### Questionário do Comportamento Alimentar do Adulto (AEBQ)

- 35 itens (frequência de ocorrência em escala de 5 pontos, de nunca a sempre).

#### Evitamento da comida

- Resposta à saciedade
- Ingestão lenta
- Selectividade alimentar
- Sub-ingestão emocional

#### Atração pela comida

- Resposta à comida
- Prazer em comer
- Sobre-ingestão emocional
- **Fome**

Hunot et al., 2016

## Evitamento da comida e atração pela comida

### Questionário do Comportamento Alimentar do Adulto (AEBQ)

- Elaborado a partir do CEBQ.
  - Alteração da formulação dos itens de “O meu filho...” para “Eu...”.
- Exclusão da sub-escala “Desejo de beber”.
  - Dificuldades na resposta, nomeadamente referência a bebidas alcoólicas ou não alcoólicas.
- Inclusão da sub-escala “Fome”.

Hunot et al., 2016; Hunot-Alexander et al., 2019

## Evitamento da comida e atração pela comida

### Fome

- Avalia aspectos físicos da fome.
- Não incluída no CEBQ por se tratar de um instrumento respondido pelos pais.
  - Já os adultos são capazes de reportar os níveis experienciados de fome.
- Não se relaciona com ingestão emocional ou restrição.
- Forte relação entre Fome e Resposta à comida, apesar de serem dimensões distintas do comportamento alimentar.
- Exemplos de itens:
  - Eu normalmente costumo sentir o meu estômago a roncar.
  - Eu fico irritada/o se saltar uma refeição.
  - Frequentemente sinto tanta fome, que preciso comer algo imediatamente.

Hunot et al., 2016; Hunot-Alexander et al., 2019

## Evitamento da comida e atração pela comida

### Relação entre as dimensões do AEBQ e do DEBQ

- Associação positiva entre a Sobre-ingestão emocional (AEBQ) e a Ingestão emocional (DEBQ).
- Associação positiva entre Resposta à comida (AEBQ) e Ingestão externa (DEBQ).
- Associação negativa da Restrição do DEBQ com as sub-escalas de atração pela comida do AEBQ.
- Associação positiva da Restrição do DEBQ com as sub-escalas de Resposta à saciedade e Ingestão lenta do AEBQ (evitamento da comida), mas negativa com Selectividade alimentar e Sub-ingestão emocional (também de evitamento da comida).

Hunot-Alexander et al., 2019